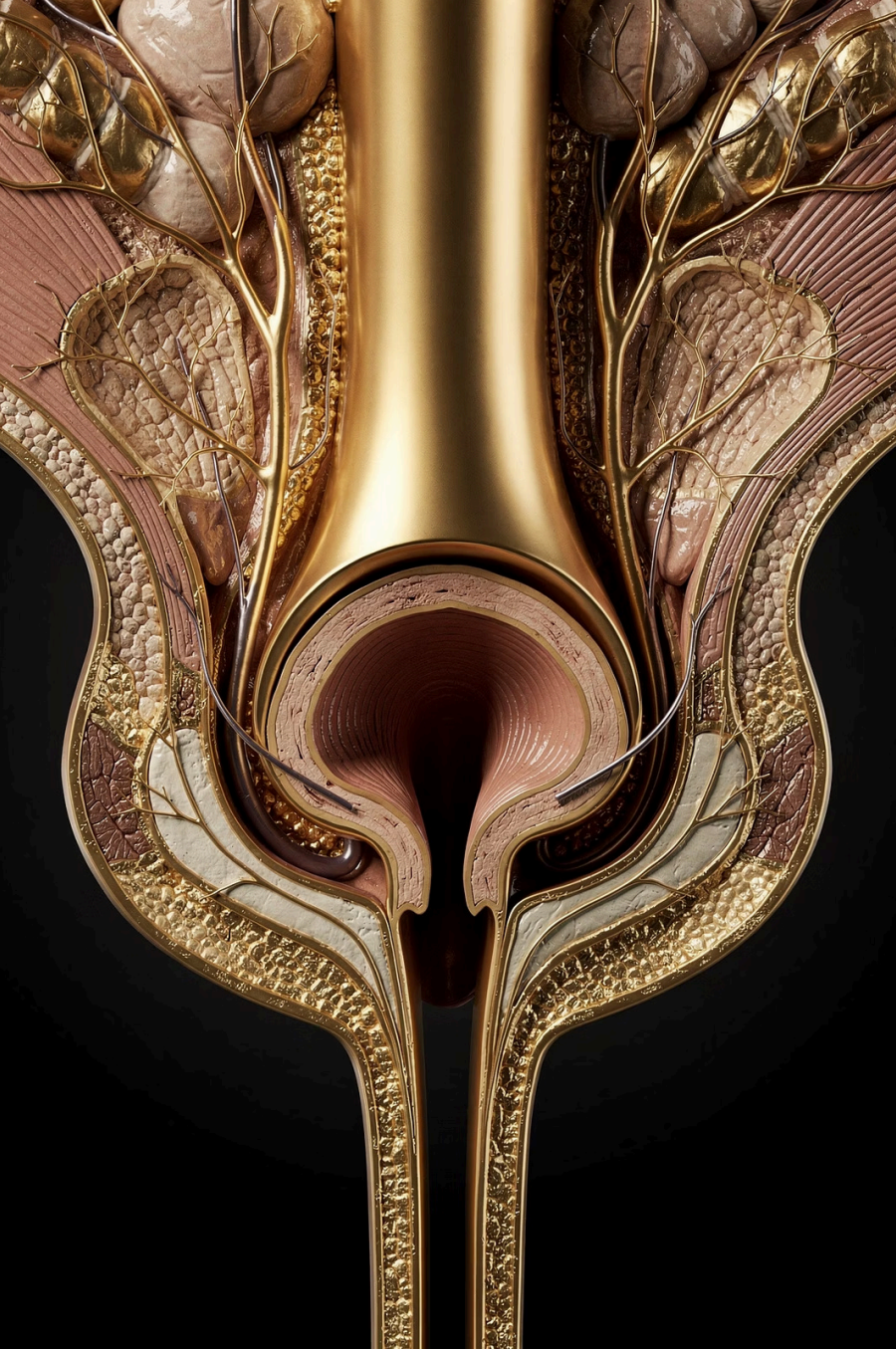




Afecções Anorretais: Doenças Comuns e Manejo Clínico

Apostila 2 — Páginas 21 a 40 | Curso de Especialização em Coloproctologia



Abscesso e Fístula



Hemorroidas



Plicomas



Condiloma Acuminado

Continuação: Abscesso Anorretal Pós-Drenagem

A drenagem cirúrgica representa o tratamento definitivo do abscesso anorretal agudo, mas **não encerra o caso clínico**. O acompanhamento rigoroso no período pós-operatório é indispensável, pois uma parcela significativa dos pacientes evolui com complicações que exigem nova intervenção.

⚠ Principal Risco Pós-Drenagem

A complicação mais temida e frequente após a drenagem de abscesso anorretal é a **formação de fistula anorretal**. Estima-se que 30 a 50% dos abscessos evoluam para fistula, especialmente quando a criptite subjacente não é tratada.

Monitoramento Pós-Operatório

- Revisão da ferida operatória em 7 a 14 dias
- Avaliação de sinais de infecção residual
- Pesquisa ativa de orifício interno (criptite)
- Orientação sobre higiene anal e banhos de assento
- Investigação de doenças de base (Crohn, imunossupressão)

📌 A drenagem sem identificação e tratamento do trajeto fistuloso primário aumenta substancialmente o risco de recidiva e formação de fístulas complexas.

Fístula Anorretal — Conceito Avançado

A fístula anorretal é definida como um **trajeto anormal, epitelizado e persistente** que comunica o interior do canal anal — geralmente a nível das criptas de Morgagni — com a pele perianal ou com estruturas adjacentes. Diferentemente dos abscessos, que representam o processo infeccioso agudo, a fístula corresponde à fase crônica da mesma enfermidade.

Patogênese Clássica

A teoria das glândulas anais de Parks postula que a infecção se origina nas glândulas de Hermann e Desfosses, localizadas no espaço interesfintérico. O processo supurativo progride, formando primeiro o abscesso e, posteriormente, o trajeto fistuloso.

Origem Mais Comum

Em **90% dos casos**, a fístula decorre de abscesso anorretal mal resolvido ou não tratado adequadamente. O orifício interno, localizado geralmente na linha pectínea, corresponde à cripta infectada de origem.

Anatomia do Trajeto

O trajeto fistuloso é composto por um **orifício interno** (no canal anal), um **trajeto primário** (que atravessa ou contorna os esfíncteres) e um **orifício externo** (na pele perianal), podendo haver trajetos secundários em casos complexos.

Causas das Fístulas Anorretais

Embora a infecção criptoglandular seja responsável pela grande maioria dos casos, o médico especialista deve estar atento a outras etiologias, especialmente quando a apresentação clínica for atípica ou quando a fístula for recidivante ou de difícil cicatrização.



Doença de Crohn

Causa importante de fístulas complexas e recidivantes. As fístulas crohnianas tendem a ser múltiplas, de difícil tratamento e frequentemente associadas a doença luminal ativa. O manejo é multidisciplinar e pode incluir terapia biológica.



Tuberculose

Embora incomum em países desenvolvidos, a tuberculose perianal deve ser considerada em populações de risco. As lesões tendem a ser indolentes, com fístulas irregulares e múltiplas. Exige confirmação histológica e microbiológica.



Neoplasias

Carcinomas do reto ou do canal anal podem fistulizar para a pele perianal ou para órgãos adjacentes. A biópsia do trajeto fistuloso é mandatória em casos suspeitos, especialmente na presença de tecido friável ou granulomatoso atípico.



Trauma e Cirurgia Prévia

Fístulas iatrogênicas podem ocorrer após hemorroidectomia, cirurgia do prolapso retal, criação de estomas ou após radioterapia pélvica. Demandam avaliação cuidadosa da integridade esfíncteriana antes de qualquer intervenção.

Quadro Clínico da Fístula Anorretal

Apresentação Típica

O quadro clínico da fístula anorretal é geralmente característico e permite o diagnóstico clínico na maioria das situações. O paciente frequentemente relata **história prévia de abscesso perianal**, drenado espontaneamente ou por cirurgia, seguida de ausência de cicatrização completa da ferida.

- **Secreção perianal contínua ou intermitente:** sero-sanguinolenta ou purulenta, manchando a roupa íntima — é o sintoma mais frequente e que leva o paciente à consulta
- **Dor local:** presente principalmente quando há processo infeccioso ativo superajuntado, formação de coleção secundária ou abscesso residual
- **Prurido e irritação perianal:** decorrentes da umidade crônica causada pela drenagem contínua
- **Orifício externo visível:** pequena abertura na pele perianal, frequentemente com granulação ao redor, identificável ao exame físico

Regra de Goodsall

Regra clínica clássica para prever o trajeto da fístula com base na posição do orifício externo em relação a uma linha transversal imaginária pelo centro do ânus:

- **Orifício externo anterior:** trajeto retilíneo ao orifício interno correspondente
- **Orifício externo posterior:** trajeto curvilíneo com orifício interno na cripta posterior média

Embora útil como guia clínico, a regra de Goodsall apresenta exceções, especialmente em fístulas anteriores com orifício distante (>3 cm) do ânus.

Diagnóstico da Fístula Anorretal

O diagnóstico da fístula anorretal é predominantemente clínico, mas a correta identificação do trajeto e do orifício interno é fundamental para o planejamento cirúrgico e para a preservação da continência fecal.

Avaliação clínica

Anuscopia

Retossigmoidoscopia

Colonoscopia

Exames de Imagem Complementares

- **Fistulografia:** método clássico, mas com limitações na delimitação de trajetos complexos
- **Ultrassonografia endoanal:** excelente para avaliar relação do trajeto com os esfíncteres
- **Ressonância magnética pélvica:** padrão-ouro para fístulas complexas, recidivantes ou associadas a Crohn

Avaliação Esfincteriana

- **Manometria anorretal:** indicada quando há suspeita de comprometimento esfinteriano prévio
- **Eletroneuromiografia:** avalia integridade neuromuscular do assoalho pélvico
- Imprescindível em mulheres, idosos e pacientes com cirurgias prévias

Diagnóstico Diferencial da Fístula Anorretal

Diversas condições podem mimetizar a fístula anorretal na apresentação clínica, com orifícios perianais e secreção local. O diagnóstico diferencial adequado evita tratamentos desnecessários ou abordagens incorretas.

● Cisto Pilonidal

Lesão cística contendo pelos, localizada na região sacrococcígea. Diferencia-se pela **localização mais superior** (sulco interglúteo), presença de pelos no trajeto e ausência de comunicação com o canal anal. Acomete preferencialmente homens jovens com hábito de vida sedentário.

● Hidradenite Supurativa

Doença inflamatória crônica das glândulas apócrinas, que pode acometer a região perianal com formação de abscessos recorrentes e trajetos fistulosos. Distingue-se pela presença de **múltiplos orifícios**, cicatrizes, ausência de comunicação com o canal anal e envolvimento de outras áreas (axilas, virilhas).

● Infecções Cutâneas

Furúnculos, foliculites profundas e infecções por *Staphylococcus* podem simular fístulas superficiais. A diferenciação é feita pela **ausência de orifício interno** no canal anal ao exame com estilete e pela resolução após antibioticoterapia ou drenagem simples sem recidiva.

📌 Em todos os casos atípicos, a biópsia do trajeto é recomendada para exclusão de neoplasia e doenças granulomatosas.

Tratamento Cirúrgico da Fístula Anorretal

O tratamento da fístula anorretal é essencialmente cirúrgico. A escolha da técnica depende da **complexidade do trajeto, da relação com o aparelho esfíncteriano e da função esfíncteriana basal** do paciente. O objetivo primordial é a cura da fístula com preservação máxima da continência fecal.

Fistulotomia

Abertura completa do trajeto fistuloso com marsupialização. Indicada para fístulas simples (interesfíntéricas e transesfíntéricas baixas) que envolvem menos de 30% do esfíncter externo. Taxa de cura elevada (>90%), com baixo risco de incontinência.

Fistulectomia

Excisão completa do trajeto fistuloso. Permite análise histológica do material ressecado. Indicada em casos selecionados; associa-se a maior taxa de incontinência por ressecção de tecido muscular.

Técnica LIFT

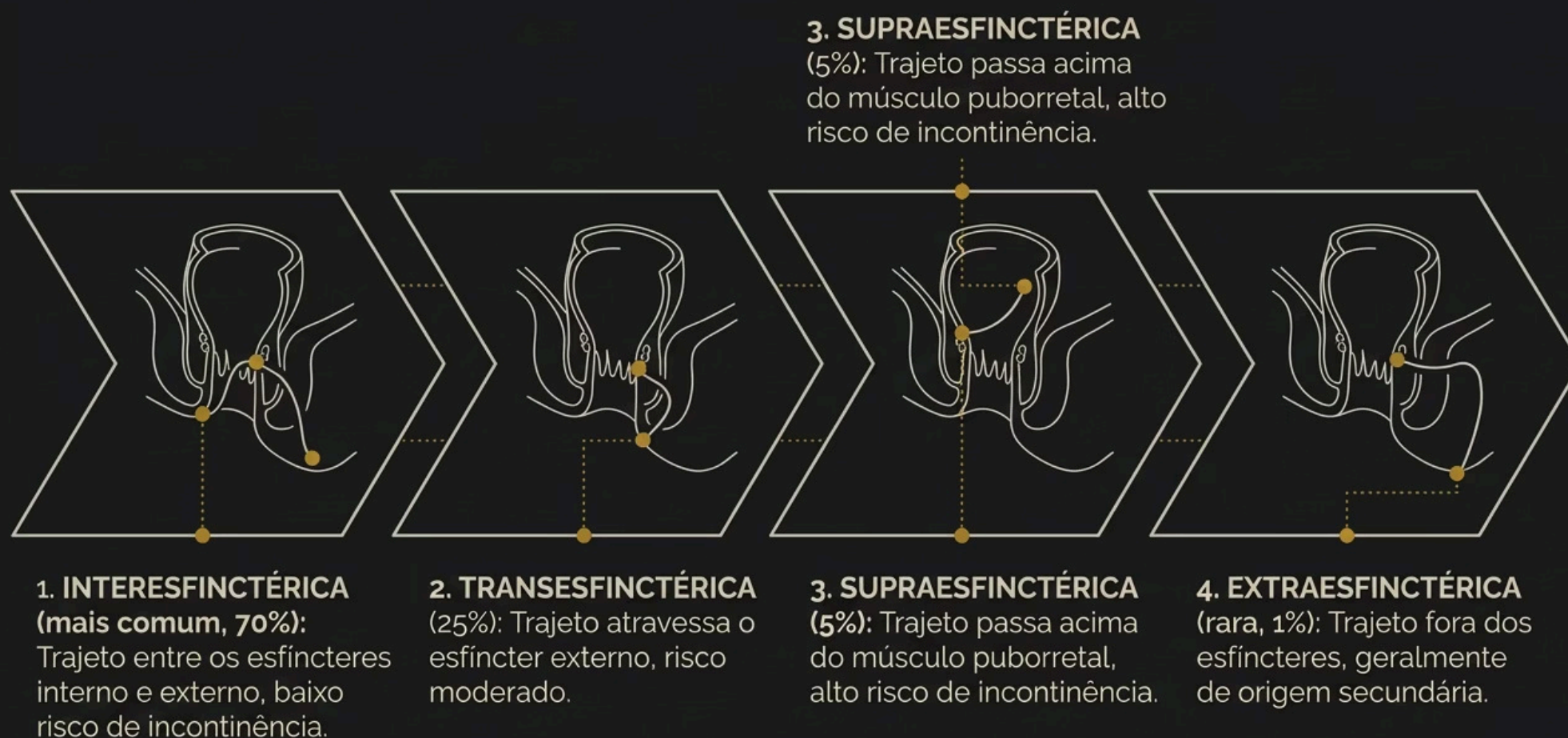
Ligation of Intersphincteric Fistula Tract. ligadura e secção do trajeto no espaço interesfíntérico. Preserva a integridade do esfíncter externo. Indicada para fístulas transesfíntéricas. Taxa de cura de 60–80%.

Cola Biológica e Plug

Alternativas minimamente invasivas para fístulas complexas ou em pacientes de alto risco cirúrgico. A cola de fibrina e o plug anorretal obliteram o trajeto sem lesão esfíncteriana. Taxas de sucesso variáveis (30–60%).

Classificação das Fístulas — Parks

A classificação de Parks, proposta em 1976, é o sistema mais amplamente utilizado na coloproctologia e divide as fístulas de acordo com a **relação anatômica do trajeto primário com o complexo esfinteriano**. Essa classificação é fundamental para o planejamento cirúrgico e para a estimativa do risco de incontinência pós-operatória.



A fístula **interesfinctérica** é a mais comum (cerca de 70% dos casos) e, em geral, a de tratamento mais simples. As fístulas **supraesfinctéricas** e **extraesfinctéricas** são raras, porém representam os maiores desafios técnicos, exigindo abordagem por cirurgiões experientes em coloproctologia avançada.

Hemorroidas — Conceito e Fisiopatologia

As hemorroidas são **estruturas vasculares normais** presentes em todos os indivíduos, compostas por plexos venosos submucosos localizados no canal anal. Sua função fisiológica inclui contribuir para a continência fecal (responsáveis por cerca de 15–20% da pressão de repouso do canal anal) e proteger o esfíncter anal durante a evacuação.

Quando se Tornam Patológicas?

A doença hemorroidária ocorre quando há **deslizamento e prolapso dos coxins vasculares**, com consequente ingurgitamento, inflamação e sintomas. A teoria mais aceita atualmente é a do deslizamento do tecido de suporte (Loder, Thomson e Phillips, 1994), que explica o prolapso progressivo.

Localização Anatômica

- **Hemorroidas internas:** acima da linha pectínea, revestidas por mucosa, inervação visceral (indolores em estágios iniciais)
- **Hemorroidas externas:** abaixo da linha pectínea, revestidas por epitélio escamoso, inervação somática (podem ser dolorosas)
- **Mistas:** envolvem ambas as regiões

Epidemiologia das Hemorroidas

A doença hemorroidária é uma das condições mais prevalentes na população adulta em todo o mundo. Sua real incidência é subestimada, pois muitos pacientes não buscam atendimento médico por constrangimento ou por considerarem os sintomas "normais".

75%

Prevalência Estimada

Proporção da população que desenvolverá hemorroidas sintomáticas em algum momento da vida

45–65

Faixa Etária de Pico

Anos de vida com maior incidência de doença hemorroidária sintomática na população geral

10M+

Consultas/Ano (EUA)

Número estimado de consultas médicas anuais motivadas por queixas hemorroidárias nos Estados Unidos

Não há diferença significativa entre os sexos na prevalência geral, embora as mulheres apresentem pico de incidência durante a **gestação e o puerpério** em razão das modificações hormonais e do aumento da pressão intrapélvica. Em homens, o sedentarismo e os hábitos alimentares inadequados são os principais fatores precipitantes.

Fatores de Risco para Doença Hemorroidária



Esforço Evacuatório

O esforço excessivo durante a defecação aumenta a pressão intra-abdominal e intrarretal, promovendo o deslizamento e ingurgitamento dos coxins hemorroidários. É considerado o principal fator de risco modificável.



Constipação Intestinal

Fezes endurecidas e trânsito lento determinam maior tempo de esforço e maior pressão sobre os plexos venosos. A constipação crônica é a principal causa subjacente em grande parte dos pacientes com hemorroidas.



Gravidez

O aumento do volume uterino comprime o retorno venoso pélvico, associado à constipação hormonal e ao esforço do parto. Hemorroidas são extremamente comuns no terceiro trimestre e no pós-parto imediato.



Sedentarismo e Postura

Permanecer longos períodos sentado (especialmente no vaso sanitário) e o sedentarismo reduzem o tônus vascular e muscular do assoalho pélvico, favorecendo a estase venosa e o prolapso dos coxins hemorroidários.

Classificação das Hemorroidas

A classificação das hemorroidas orienta diretamente as decisões terapêuticas. As hemorroidas internas são graduadas segundo o sistema de Goligher, que avalia o grau de prolapso e sua redutibilidade.

Hemorroidas Internas — Graus de Goligher

- **Grau I:** Ingurgitamento sem prolapso. Sangramento ao esforço. Não visíveis ao exame externo. Diagnóstico por anoscopia.
- **Grau II:** Prolapso durante a evacuação com redução espontânea. Sangramento frequente.
- **Grau III:** Prolapso que necessita de redução manual. Sintomas mais intensos, com muco e desconforto.
- **Grau IV:** Prolapso irreduzível permanente. Risco de trombose e estrangulamento. Indicação cirúrgica absoluta.

Hemorroidas Externas

Localizadas abaixo da linha pectínea, as hemorroidas externas são revestidas por epitélio escamoso e possuem **inervação somática**, tornando-as sensíveis à dor. Sua principal complicação é a **trombose aguda**, que causa dor intensa, súbita e localizada, com nódulo azulado, firme e doloroso à palpação.

A trombose hemorroidária externa é uma urgência coloproctológica. Quando tratada nas primeiras 72 horas, a trombectomia sob anestesia local proporciona alívio imediato dos sintomas.

Tratamento Conservador das Hemorroidas

O tratamento conservador é a **primeira linha terapêutica** para a grande maioria dos pacientes com doença hemorroidária sintomática, especialmente nos graus I e II. O objetivo é reduzir os sintomas, corrigir os fatores predisponentes e evitar a progressão da doença.

1

Banho de Assento

Realizado com água morna (não quente) por 10 a 15 minutos, 2 a 3 vezes ao dia e após as evacuações. Reduz o espasmo do esfíncter interno, alivia a dor e o prurido, e favorece a higiene local. Não deve conter substâncias irritantes (permanganato, sabões fortes).

2

Dieta Rica em Fibras e Hidratação

Ingestão de 25 a 35 g de fibras/dia (frutas, vegetais, grãos integrais) e 1,5 a 2 litros de água/dia. Amolece as fezes, reduz o esforço evacuatório e diminui o tempo de trânsito intestinal — atacando diretamente o principal fator de risco.

3

Laxantes Osmóticos

Polietilenoglicol, lactulose ou psyllium são indicados quando a modificação dietética isolada é insuficiente para regularizar o trânsito intestinal. Evitar laxantes estimulantes pelo risco de dependência e distúrbios eletrolíticos.

4

Pomadas e Supositórios Tópicos

Formulações com corticosteroides, anestésicos locais e venotônicos (diosmina, hesperidina) reduzem a inflamação, o prurido e o edema. Uso restrito a curtos períodos (máximo 2 semanas com corticoides) para evitar atrofia e dermatite de contato.

Tratamentos Intervencionistas para Hemorroidas

Quando o tratamento conservador não obtém resposta satisfatória após 4 a 6 semanas, ou em hemorroidas de grau II e III, os procedimentos intervencionistas ambulatoriais são indicados antes de se cogitar a cirurgia.

Ligadura Elástica

Método mais utilizado mundialmente para hemorroidas internas de grau I a III. Anel elástico provoca isquemia e necrose do tecido, com queda em 7 a 10 dias. Alta taxa de sucesso (>80%). Pode ser repetido em sessões.



Escleroterapia

Injeção de agente esclerosante (fenol a 5% em óleo vegetal ou polidocanol) na submucosa acima da hemorroida. Provoca fibrose e redução do aporte vascular. Indicada para hemorroidas grau I e II com sangramento predominante.

Fotocoagulação por Infravermelho

Aplicação de pulsos de infravermelho que coagulam e fibrosam o tecido hemorroidário. Indicada para hemorroidas de pequeno volume (grau I e II). Procedimento rápido, bem tolerado, com baixa taxa de complicações.



Crioterapia

Destruição do tecido hemorroidário por congelamento com nitrogênio líquido. Menos utilizada atualmente em razão da dificuldade em controlar a extensão da necrose e do maior desconforto pós-procedimento comparado a outras técnicas.

Tratamento Cirúrgico das Hemorroidas

A hemorroidectomia é indicada para hemorroidas de **grau III refratárias ao tratamento clínico e intervencionista** e para todas as hemorroidas de **grau IV**. É também a opção quando há trombose extensa, hemorroidas mistas volumosas ou preferência do paciente após esclarecimento adequado.

Técnicas Cirúrgicas

- **Hemorroidectomia aberta (Milligan-Morgan):** excisão dos mamilos hemorroidários com feridas abertas para cicatrização por segunda intenção. Técnica clássica, amplamente utilizada; recuperação mais longa
- **Hemorroidectomia fechada (Ferguson):** sutura das feridas após excisão. Cicatrização mais rápida, menor desconforto. Preferida em muitos centros norte-americanos
- **Grampeamento (PPH — Procedure for Prolapse and Hemorrhoids):** ressecção circular da mucosa prolapsada com grampeador. Reduz o prolapso e o aporte vascular. Menos dor pós-operatória, porém com risco de estenose e recidiva a longo prazo

Cuidados Pós-Operatórios

- Analgesia multimodal (AINE + paracetamol ± opioide fraco)
- Banhos de assento mornos 2–3x/dia
- Dieta rica em fibras e laxante osmótico por 30 dias
- Curativo local e higiene cuidadosa
- Retorno em 15 dias para avaliação da ferida
- Afastamento laboral de 7 a 14 dias (trabalho físico: até 30 dias)

Complicações da Doença Hemorroidária

As complicações podem decorrer da própria evolução natural da doença hemorroidária ou ser consequência dos tratamentos intervencionistas e cirúrgicos. O reconhecimento precoce e o manejo adequado são fundamentais para evitar sequelas permanentes.

Sangramento

Hematoquezia (sangue vermelho vivo no papel ou na tigela) é o sintoma mais comum. Hemorroidas de grau I e II sangram com mais frequência. Sangramento volumoso pode causar anemia ferropriva crônica. Diagnóstico diferencial com câncer colorretal é obrigatório em pacientes acima de 40 anos.

Dor e Trombose

Trombose hemorroidária externa é a complicação mais dolorosa. Caracteriza-se por nódulo perianal azulado, tenso e muito doloroso de instalação aguda. A trombectomia nos primeiros 3 dias é o tratamento de eleição; após esse prazo, o tratamento conservador com resolução espontânea em 7 a 14 dias é preferível.

Infecção Pós-Operatória

Infecção das feridas cirúrgicas pode ocorrer, especialmente em imunossuprimidos. A fasciite necrosante perianal (gangrena de Fournier) é complicação rara, porém potencialmente fatal, que exige desbridamento cirúrgico urgente e antibioticoterapia de amplo espectro.

Incontinência e Estenose Anal

A incontinência fecal pode decorrer de lesão esfínteriana iatrogênica durante cirurgia. A estenose anal é complicação tardia da hemorroidectomia, causada por excesso de ressecção mucosa. Sua prevenção exige manutenção de pontes de mucosa íntegras entre os mamilos ressecados.

Plicomas e Condiloma Acuminado (HPV)

LESÕES PERIANAIS BENIGNAS

Plicomas Anais

Os plicomas são dobras de pele redundante localizadas na margem anal, frequentemente resultantes de hemorroidas externas trombosadas prévias, processos inflamatórios cicatrizados ou sequelas cirúrgicas. Representam tecido fibroso e vascular organizado.

Características clínicas:

- Geralmente assintomáticos — achado incidental ao exame
- Podem causar desconforto local, sensação de corpo estranho ou prurido
- Dificultam a higiene perianal adequada, predispondo a dermatite e infecções secundárias
- Não têm potencial maligno

Tratamento: excisão cirúrgica eletiva, indicada apenas quando sintomáticos ou quando comprometem a higiene. Procedimento simples, realizado sob anestesia local em regime ambulatorial.

Condiloma Acuminado (HPV)

Lesões verrucosas causadas pelo **Papilomavírus Humano (HPV)**, principalmente genótipos 6 e 11 (baixo risco) e 16 e 18 (alto risco oncogênico). Transmissão predominantemente sexual; período de incubação de semanas a meses.

Características importantes:

- Crescimento progressivo — podem atingir grandes proporções (*condiloma gigante de Buschke-Löwenstein*)
- Localização: perianal, intrarectal — **não ultrapassa a linha pectínea** para a região intra-anal superior
- Mais agressivos e extensos em **imunossuprimidos** (HIV, transplantados, uso de corticoides)
- Risco de transformação maligna com genótipos de alto risco

Diagnóstico e Tratamento do Condiloma Acuminado

O condiloma acuminado perianal é uma das infecções sexualmente transmissíveis mais comuns. Seu diagnóstico e tratamento adequados são fundamentais para o controle da transmissão, alívio dos sintomas e prevenção de complicações oncológicas.

Diagnóstico

- **Clínico:** na maioria dos casos, as lesões verrucosas perianais têm aspecto característico, permitindo o diagnóstico visual. Anuscopia é obrigatória para avaliar extensão intracanal
- **Biópsia:** indicada quando há suspeita de carcinoma escamocelular (lesões ulceradas, friáveis, fixas ou com crescimento rápido), lesões atípicas que não respondem ao tratamento, ou em imunossuprimidos com apresentação incomum
- **Tipagem viral (HPV):** não é rotineira no diagnóstico inicial, mas pode ser útil na avaliação de recidivas e risco oncogênico
- **Sorologia para ISTs:** HIV, sífilis e outras ISTs devem ser pesquisadas em todos os pacientes com condiloma

Opções Terapêuticas

- **Ácido tricloroacético (ATA):** aplicação tópica em consultório. Eficaz para lesões pequenas e isoladas. Necessita repetição semanal por várias sessões
- **Imiquimode creme 5%:** imunomodulador de uso domiciliar. Estimula a resposta imune local. Aplicação 3x/semana por até 16 semanas
- **Eletrocauterização ou laser CO₂:** destruição das lesões por energia térmica. Indicado para lesões extensas ou resistentes aos tratamentos tópicos
- **Excisão cirúrgica:** preferida para lesões volumosas, condiloma gigante ou quando há suspeita de malignidade. Permite análise histológica
- **Vacinação contra HPV:** profilática; recomendada antes do início da vida sexual, mas com benefício mesmo em adultos jovens

❏ A recidiva do condiloma é frequente (20–50%), mesmo após tratamento adequado, em razão da persistência viral latente. O seguimento a longo prazo é obrigatório, com anuscopia e colposcopia anal anual em pacientes de alto risco.

Síntese e Pontos-Chave da Apostila 2

Esta apostila abordou as principais afecções anorretais com foco em diagnóstico clínico e raciocínio terapêutico. Os pontos abaixo sintetizam o conhecimento essencial que o especialista deve dominar.

1 Abscesso → Fístula: entender a continuidade fisiopatológica

Todo abscesso anorretal pode evoluir para fístula. O acompanhamento pós-drenagem e a identificação precoce do trajeto fistuloso são determinantes para o prognóstico.

2 Classificação de Parks: guia fundamental para o tratamento cirúrgico

A relação do trajeto fistuloso com o complexo esfinteriano define a técnica cirúrgica e o risco de incontinência. Fistulotomia para fístulas simples; LIFT e retalhos para fístulas complexas.

3 Hemorroidas: diagnóstico clínico + classificação de Goligher orientam o tratamento

Graus I–II: tratamento conservador e intervencionista. Graus III–IV: cirurgia. A trombose hemorroidária externa é urgência e deve ser tratada nas primeiras 72 horas.

4 Condiloma: rastreio de ISTs, biópsia seletiva e seguimento oncológico

HPV de alto risco exige vigilância prolongada. Imunossuprimidos têm apresentação mais agressiva. A vacinação profilática é a medida preventiva mais eficaz disponível.

Referências: Diretrizes da Sociedade Brasileira de Coloproctologia • American Society of Colon and Rectal Surgeons (ASCRS) Guidelines • Parks AG, Gordon PH, Hardcastle JD. A Classification of Fistula-in-Ano. *Br J Surg*. 1976.